Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Sobradinho

Rua Capitão Veríssimo, 556 - Bairro: Centro - CEP: 96900000 - Fone: (51) 3098-5798 - Balcão Virtual: (51) 99850 1136 (somente wpp) - Email: frsobradin2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002753-29.2024.8.21.0134/RS

AUTOR: VANDERLEI SERGIO LAZZAROTTO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I - RELATÓRIO.

VANDERLEI SERGIO LAZZAROTTO, já qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO COMINATÓRIA com pedido de TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE-SAÚDE, igualmente qualificado. Narra o autor, em sua petição inicial, ser beneficiário do plano de saúde gerido pelo réu e portador de neoplasia maligna de fígado (hepatocarcinoma) em estádio avançado (BCLC-C, CID C22). Informou que, após a falha de tratamentos anteriores, seu médico assistente prescreveu, em caráter de urgência, o uso contínuo do medicamento **CABOZANTINIBE 60mg** (Cabometyx), como única alternativa terapêutica viável para controle da doença, aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida. Alegou que a cobertura do fármaco foi negada administrativamente pelo IPE-SAÚDE, sob o argumento de que o tratamento não consta em suas tabelas e protocolos. Defendeu a abusividade da negativa, sustentando que, uma vez coberta a patologia (câncer), o plano não pode limitar os meios necessários ao seu tratamento. Fundamentou seu direito na legislação aplicável e em precedentes judiciais, destacando o risco de progressão da doença e óbito. Requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que o réu autorizasse e custeasse o tratamento. Ao final, pugnou pela confirmação da liminar e a procedência do pedido. Juntou documentos - evento 1, INIC1.

Inicialmente distribuído à Justiça Estadual, o feito foi remetido à Justiça Federal após determinação para inclusão da União no polo passivo, com base no Tema 1.234 do STF - evento 4, DESPADEC1.

Na esfera federal, foi produzida Nota Técnica pelo NAT-Jus - evento 26, NOTATEC1. Posteriormente, a Justiça Federal excluiu a União da lide e declinou novamente da competência, determinando o retorno dos autos a este juízo estadual - evento 28, DESPADEC1.

Ao receber o processo, este juízo deferiu o pedido de gratuidade da justiça e concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando ao IPE-SAÚDE o fornecimento do medicamento no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de valores - evento 35, DESPADEC1. O réu cumpriu a decisão liminar - evento 40, OFIC1.

Citado, o IPE-SAÚDE apresentou contestação. Em sua defesa, argumentou ser uma autarquia que opera plano de saúde na modalidade de autogestão, não se submetendo às normas do Código de Defesa do Consumidor. Afirmou que sua atuação é pautada pelo princípio da legalidade e que a cobertura é restrita aos procedimentos previstos em seus regulamentos (Lei Complementar n.º 15.145/2018). Salientou que o medicamento pleiteado não integra seus protocolos para a patologia do autor e que a inclusão de novas tecnologias depende de critérios de eficácia e custo-efetividade, que não seriam atendidos no caso. Sustentou que a concessão judicial do tratamento comprometeria o equilíbrio financeiro do sistema. Pugnou pela improcedência da ação - evento 41, PET1.

Houve réplica - evento 45, RÉPLICA1.

Instadas a especificar provas, as partes quedaram-se inertes, sendo declarada encerrada a instrução.

Ambas as partes apresentaram memoriais, ratificando suas posições anteriores - evento 62, MEMORIAIS1 e evento 63, MEMORIAIS1.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório, em síntese, por ora necessário. Passo à fundamentação, e, na sequência, a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO.

O feito transcorreu regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não havendo questões preliminares a serem dirimidas, passo diretamente à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir se o IPE-SAÚDE tem o dever de custear o tratamento do autor com o medicamento ***CABOZANTINIBE 60mg***, embora este não conste expressamente nos protocolos da autarquia para a patologia que o acomete.

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, assim como o diagnóstico do autor – *neoplasia maligna de fígado (hepatocarcinoma) em estádio BCLC-C* – e a prescrição médica para o uso do fármaco em questão, conforme se extrai do laudo médico anexado no evento 1, LAUDO7:

Atestado Médico

Atesto que VANDERLEI SERGIO LAZZAROTTO tem diagnóstico de patologia CID C22 - neoplasia maligna de fígado (hepatocarcinoma) em estádio BCLC-C. Não tem indicação atual de tratamentos ablativos locais, embolizações ou abordagens cirúrgicas. Foi previamente submetido à tratamento com outros inibidores tirosino-quinases, tendo apresentado progressão de doença (falha terapêutica) na vigência dos seus usos. Apesar disso, segue com desempenho clínico e função hepática compatíveis com a utilização de estratégias de linhas subsequentes, tendo recebido a indicação de uso da medicação CABOZANTINIBE. Ressalta-se que o paciente é transplantado hepático, havendo limitação para exposição à imunoterapia.
O CABOZANTINIBE (nome comercial CABOMETYX) é utilizado na dose total de 60mg por dia, em caráter contínuo.. O paciente seguirá sendo submetido a avaliações clínicas, laboratoriais e radiológicas em caráter periódico, sendo a droga mantida por prazo indeterminado enquanto a relação entre benefício clínico e toxicidade se mantiver favorável.
O uso da medicação citada, nesse contexto clínico, é amparado por indicação na bula brasileira do fármaco e por consensos técnicos de reconhecimento internacional como o NCCN (National Comprehensive Cancer Network; http://nccn.org). Há evidências clínicas em ensaios de fase III que demonstram benefícios em sobrevida (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1717002).
A história natural da patologia citada quando não exposta a medicações que possam alterar a sua história natural (como o CABOZANTINIBE) é de piora clínica progressiva, expansão do volume tumoral, aumento do comprometimento funcional dos órgãos acometidos e substancial aumento do risco de morte.
Dado o exposto, ratifica-se a indicação de início de uso da medicação CABOZANTINIBE para o paciente, sem interrupções não-programadas e associada com a manutenção do acompanhamento oncológico vigente.

15 de Outubro de 2024

O réu fundamenta sua recusa na ausência de previsão do tratamento em seus regulamentos internos, com base no artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 15.145/2018, que exclui da cobertura procedimentos não previstos nas tabelas do Instituto. Invoca, ainda, a natureza de autogestão do plano e a necessidade de preservar sua sustentabilidade financeira.

> *Art. 4.º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor. § 1.º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.*

A tese, contudo, não merece prosperar.

O direito à saúde é garantia fundamental, inscrita no artigo 196 da Constituição Federal como "*direito de todos e dever do Estado*". Embora o IPE-SAÚDE não integre o Sistema Único de Saúde (SUS), mas sim a saúde suplementar, os contratos e planos de assistência à saúde devem ser interpretados à luz dos direitos fundamentais, em especial o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

É pacífico o entendimento de que os planos de saúde, mesmo os de autogestão, podem estabelecer quais doenças são cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura ou controle dessas enfermidades. A escolha da terapia mais adequada cabe exclusivamente ao médico que acompanha o paciente, e não à operadora do plano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e firme no sentido de que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado:

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É abusiva a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1353634/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019)*

> *PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. DEVER DE COBERTURA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 469 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1374307/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)*

Também destaco a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça:

> *APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) E AXITINIBE (INLYTA) PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. Apelo da parte autora: Hipótese dos autos em que o recurso da parte autora versa exclusivamente acerca da majoração dos honorários sucumbenciais. O procurador da parte autora não é beneficiário da gratuidade judiciária, não efetuou o preparo no ato da interposição da apelação (art. 99, §5º, do CPC), tampouco atendeu à determinação para proceder ao pagamento em dobro, na forma do art. 1007, §4º, do CPC/15. Nesse contexto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade, imperioso não conhecimento do recurso, porquanto deserto. Apelo da Autarquia: Fornecimento de medicamentos fora dos protocolos**. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento da autarquia previdenciária não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento dos medicamentos ora solicitados, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia ao fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas.** APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50090431620218210021, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 15-12-2022) Grifei*

No caso em tela, a patologia do autor (câncer) possui cobertura pelo plano do IPE-SAÚDE, que prevê a especialidade de oncologia em seus regulamentos. A negativa de fornecimento do medicamento prescrito pelo especialista, sob o pretexto de não constar em uma lista interna, representa uma limitação abusiva ao próprio direito à saúde contratado. Tal conduta esvazia o objeto principal do plano, que é justamente garantir a assistência necessária ao beneficiário no momento de enfermidade.

A exclusão de cobertura para um tratamento essencial a uma doença coberta viola a boa-fé objetiva e a própria finalidade do serviço prestado. O rol de procedimentos e as tabelas internas das operadoras de saúde servem como referência mínima e não podem ser interpretados de forma a restringir o acesso a tratamentos modernos e eficazes, indicados como a única opção viável pelo profissional de saúde.

Portanto, a recusa do réu é ilegítima. Uma vez que a doença está coberta, o tratamento necessário para combatê-la, devidamente prescrito pelo médico assistente, deve ser igualmente custeado, sob pena de se tornar inócua a própria cobertura assistencial.

Dessa forma, a confirmação da tutela de urgência e a procedência do pedido são medidas que se impõem.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por VANDERLEI SERGIO LAZZAROTTO em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE-SAÚDE, com fulcro no artigo 487, inc. I, do CPC, para, confirmando a tutela de urgência deferida no evento 35, DESPADEC1, condenar o réu à obrigação de fazer consistente no fornecimento e custeio integral do medicamento CABOZANTINIBE 60mg, na forma e quantidade prescritas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, a ser aferida por meio de relatórios médicos periódicos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado. A exigibilidade das custas devidas pelo réu observará a legislação aplicável à Fazenda Pública.

Com o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **HAM MARTINS REGIS, Juiz de Direito**, em 18/11/2025, às 13:54:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10095112545v52** e o código CRC **583472a6**.